

Maio 2026

Asma - Fisiopatologia e Diagnóstico

Em maio de 2026, foi publicado o **GINA 2026**, com ajustes importantes no tratamento ambulatorial alternativo, na asma grave e na exacerbação (crises). Pensando na sua prova de residência, destacamos os pontos-chave de forma resumida:

Diagnóstico — o que ficou

- **Critério de broncodilatador positivo MANTIDO:** aumento do **VEF₁** ou **CVF** $\geq 12\%$ E ≥ 200 mL (ERS/ATS 2005). A proposta de 2022 de usar **> 10% do predito foi rejeitada** — geraria subdiagnóstico, especialmente em homens jovens.

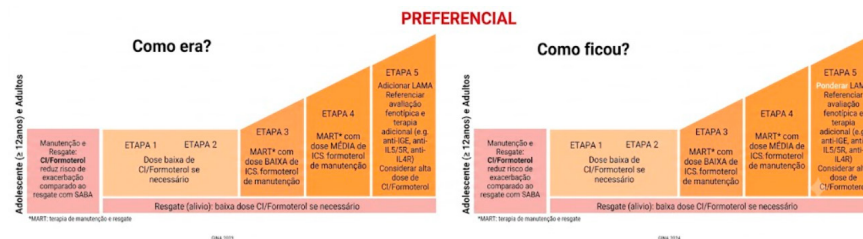
Referência: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). Global strategy for asthma management and prevention: 2026 update. [S. l.]: GINA, 2026. Disponível em: GINA 2026 Strategy Report. Acesso em: 7 maio 2026.

Asma - Ambulatorial (CM)

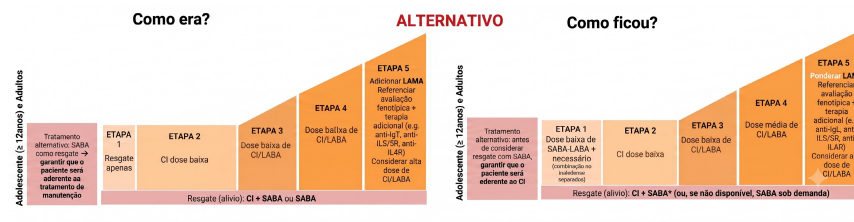
Em maio de 2026, foi publicado o **GINA 2026**, com ajustes importantes no tratamento ambulatorial alternativo, na asma grave e na exacerbação (crises). Pensando na sua prova de residência, destacamos os pontos-chave de forma resumida:

Tratamento ambulatorial — o que mudou do GINA 2025 para o GINA 2026

- **Trilha 1 (preferencial) – mudança discreta:**
 - **ICS-formoterol** como aliviador anti-inflamatório (AIR/MART) **em todas as etapas** continua sendo o esquema preferencial para adultos e adolescentes ≥ 12 anos.
 - Etapa 5: “**Adicionar LAMA**” virou “**Ponderar LAMA**” — agora há a tripla combinação **budesonida-formoterol-glicopirrônio** como opção, mas a redução de exacerbações com tripla terapia é **menor** do que com biológicos.



- **Trilha 2 (alternativo) – principal mudança = abandono do SABA isolado:**
 - Paciente **nunca recebe broncodilatador sozinho**
 - O **ICS-SABA como aliviador (resgate)** agora se estende a **todas as etapas** do Trilha 2.
 - **Etapa 1 (NOVO):** entra o **AIR com ICS-SABA combinado** (ou ICS + SABA tomados juntos). Baseado no estudo **BATURA** (redução de exacerbações graves em ~50% vs SABA isolado).
 - Etapa 5 também passou de “Adicionar” para “**Ponderar LAMA**”.



Tratamento da asma grave — o que mudou

- **Conceito (relembrando):**
- **Asma de difícil controle:** Pacientes com ICS em dose média/alta associado a uma segunda droga (geralmente LABA), ou seja, STEPs 4/5 ou uso de corticoide oral $\geq 50\%$ dias, com a doença **não controlada** devido a **um ou mais fatores** que influenciam no controle da doença, podendo ser técnica inadequada, fatores ambientais, etc;
- **Asma grave:** Pacientes com ICS em dose média/alta associado a uma segunda droga (geralmente LABA), ou seja, STEPs 4/5 ou uso de corticoide oral $\geq 50\%$ dias, com a doença **não controlada** mas já revisado boa adesão e controle ambiental!
 - **Asma grave** é igual **fenotipar** (Eos/FeNO/teste de alergia) para guiar terapêutica

- **Atualização dos fluxogramas de tratamento**
- **Novo biológico: Depemokimab:** anti-IL-5 de longa duração
- **Anti-IgE** (omalizumabe)
 - Asma de início na infância +
 - Sintomas desencadeados por alérgenos +
- **Anti-IL5/Anti-IL5R** (benralizumabe, mepolizumabe, reslizumabe, **depemokimab**)
 - Eosinofilia +++
 - Exacerbações no último ano +++
 - Asma de início na vida adulta ++
 - Polipose nasal ++
- **Anti-IL4Ra** (dupilumabe)
 - Eosinofilia +++
 - FeNO em níveis elevados +++
 - Polipose nasal ++

- **Anti-TSLP** (tezepelumabe)
 - Eosinofilia +++
 - FeNO em níveis elevados +++
 - Polipose nasal ++

Referência: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). Global strategy for asthma management and prevention: 2026 update. [S. l.]: GINA, 2026. Disponível em: GINA 2026 Strategy Report. Acesso em: 7 maio 2026.

Asma - Exacerbação

Em maio de 2026, foi publicado o **GINA 2026**, com ajustes importantes no tratamento ambulatorial alternativo, na asma grave e na exacerbação (crises). Pensando na sua prova de residência, destacamos os pontos-chave de forma resumida:

Tratamento da crise (exacerbação) — o que mudou

- **Fluxogramas divididos por cenários**
 - Atenção primária
 - Emergência
- Melhor estratificação da **gravidade**
 - Como era (2): crise leve-moderada e crise grave
 - Como ficou (4): crise leve, moderada, grave e ameaçadora à vida
- **Anafilaxia em primeiro lugar:** se houver anafilaxia concomitante, **epinefrina IM (ou intranasal) antes** dos broncodilatadores.
- **Alvos de oxigênio mais conservadores:**
 - O₂ suplementar **apenas se SatO₂ < 92%**;
 - SatO₂ alvo **92–95%** em adultos e crianças 6–11 anos (evitar hiperóxia).
- **Doses de SABA mais conservadoras:**
 - Risco de **toxicidade do SABA**
 - Taquicardia, tremor, hipocalemia e **acidose láctica**, com **hiperventilação compensatória**
 - **Pode ser confundida com piora da asma** e levar a mais SABA num ciclo perigoso.
- **ICS-formoterol como opção na crise leve em adultos** (alternativa ao SABA inalado)
 - Funciona como ponte para iniciar/intensificar o tratamento preventivo na alta.
- **Uso parcimonioso dos corticoides orais (OCS) reforçado:**
 - Otimizar inalatório, indicar biológico quando elegível, evitar manutenção com OCS, monitorar uso cumulativo.

	Leve (todos os critérios)	Moderado (considerar tais critérios)	Grave (qualquer um dos critérios)	
Fala	Sentenças completas	Frases	Incapaz de conversar ou beber	
Posição	Consegue deitar	Prefere sentar a ficar deitado	Incapaz de se deitar	
Exame pulmonar	Sem uso de musculatura acessória ou sibilo expiratório	Uso de musculatura acessória ou sibilo expiratório	Tórax silente	
FR	Normal ou taquipneia discreta	Taquipneia	> 30irpm	
SatO2	≥ 94%	≥ 92%	< 92%	
PFE ou VEF1 (melhor basal/ predito)	> 70%	50-70%	< 50%	
PRAM (< 18anos)	1-3	4-7	8-10	

Tratamento inicial (atenção primária)	Salbutamol (4 puffs) ou Bud-form (2 puffs) Checar resposta e repetir em 30-60min S/N	Salbutamol (4-6 puffs) até 3x S/N Se ipratrópio disponível/indicado (4 puffs) associar Corticoide sistêmico	Transferir para serviço de emergência <u>Iniciar tratamento imediato</u> Se anafilaxia e asma: epinefrina Salbutamol (6-10 puffs), repetir S/N a cada 20-30min Se ipratrópio disponível (4 puffs) associado ao salbutamol, por até 3x O2 suplementar (SatO2 92-95%)	
			Corticoide sistêmico	
Tratamento inicial (emergência)			Mesmo acima + Considerar magnésio EV	

Referência: GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA (GINA). Global strategy for asthma management and prevention: 2026 update. [S. l.]: GINA, 2026. Disponível em: GINA 2026 Strategy Report. Acesso em: 7 maio 2026.

[Acesse o blog MedCof](#)